

Normalità e Patologia nell'Età Evolutiva — Schema

I Tempi della Vita · Sessione 08

Definizioni di normalità (Marcelli, 1999)

- **Media statistica** → normale = entro $\pm 1\sigma$ dalla media (es. QI 85-115, BMI 18,5-24,9)
 - Rischio: diventa prescrittiva, ignora la qualità
 - **Ideale** → normale = risponde alle attese di genitori/scuola/società
 - Rischio: chi definisce l'ideale?
 - **Processo dinamico** → normale = adattivo, resiliente
 - **Assenza di malattia** → normale = non malato (definizione circolare)
-

Sintomo vs Segno

- **Sintomo** → manifestazione soggettiva riferita dal paziente
- **Segno** → fenomeno oggettivo, misurabile dall'esterno
- In psicoanalisi: sintomo = compromesso tra pulsione e difesa → **tentativo di guarigione**

Sintomo nel bambino (Winnicott)

- **Bambino sano** → repertorio flessibile di sintomi
- **Falso sé** → assenza totale di sintomi = segnale di allarme
- **Patologia** → rigidità e limitazione nell'uso dei sintomi

Funzioni del sintomo in età evolutiva

- Cerca organizzazione interna più adattativa

- Richiesta verso i caregiver
- Ricerca di significato (quando mancano simbolizzazioni mature)

Sintomi nelle fasi di transizione

- Compaiono quando la fase evolutiva fa richieste elevate alla personalità
- Possono traghettare transitoriamente il bambino oltre il periodo difficile

Due difficoltà della psicologia clinica

- **Assenza di markers biologici** → nessun esame conferma la diagnosi
- **Assenza di sintomi patognomonici** → quasi nessun sintomo è univoco

Sintomo	Diagnosi possibili
Ansia	Presente in quasi tutti i disturbi psichiatrici
Anedonia	Adolescenza normale / depressione / psicosi
Dispercezioni	Esordio psicotico / sostanze / disturbo del sonno

- ⚠ Sintomi **silenziosi** (negativi) spesso più gravi di quelli rumorosi
- 75-90% esperienze psicotiche subcliniche sono transitorie (prevalenza clinica ~5%)
- **Pruning** neuronale → alleato della salute psichica nella maturazione

I quattro assi della valutazione

1. Asse Sindromico-Sintomatico

Area del corpo: - Sfera oro-alimentare · sonno · controllo sfinterico · condotte sessuali · motricità

Area del comportamento: - Alterazioni comportamentali · aggressività · affettività · cognizione · linguaggio · regolazione

2. Asse Strutturale

Autore	Opera	Criteri diagnostici
Bergeret	<i>La personalità normale e patologica</i> , 1974	Sintomi · difese · tipo di angoscia · relazione d'oggetto
Kernberg	<i>Disturbi gravi della personalità</i> , 1984	Sintomi · identità (integrazione/dispersione) · difese · esame della realtà
Palacio Espasa & Dufour	Diagnosi strutturale in età evolutiva	Impressione generale · relazione con esaminatore · funzioni dell'Io · affetti · difese · pulsioni/fantasmi · Super-Io · immagine di sé

Domanda chiave: sintomo = **in relazione** con la maturazione **oppure** ostacolo a essa?

3. Asse Evolutivo

Regressioni e fissazioni: - Tendenze regressive normali nei momenti di transizione - Si organizzano attorno a **punti di fissazione**

Linee evolutive del bambino: - Dipendenza → autonomia affettiva - Assenza di controllo → pieno controllo sfinterico - Egocentrismo → socievolezza - Gioco autoerotico → oggetto transizionale → gioco simbolico

Compiti evolutivi dell'adolescente: - Mentalizzazione del sé corporeo - Separazione-individuazione - Formazione di valori - Nascita sociale

Fenomeni normali spesso scambiati per patologia: - Dismorfofobia lieve (corpo che cambia) - Condotte a rischio (appetenza evolutiva del cervello adolescente) - Fobie specifiche (~2 anni: emergono immaginazione e paure irrazionali) - Ossessioni circoscritte nella fase di latenza

4. Asse Ambientale

- **Microsistema** → esperienza diretta: famiglia, relazione genitori-bambino, fantasie del genitore
 - **Mesosistema** → contesti indiretti che influenzano il bambino (es. rapporto scuola-famiglia)
 - **Macrosistema** → cultura, norme, valori di riferimento
-

Processo di valutazione psicologica

1. Richiesta di consultazione
 2. Anamnesi
 3. Incontri (genitori · bambino · interazione · gioco/disegno · scuola)
 4. Esami strumentali
 5. Riflessione
 6. **Restituzione** → ipotesi diagnostiche · descrizione funzionamento unico · prognosi · proposta terapeutica
-

Caso James — Applicazione dei quattro assi

Asse	Elementi rilevati
Sindromico	Sonno disturbato, autoregolazione deficitaria, aggressività, quota ansiosa
Strutturale	Sguardo sfuggente, umore deflesso, contenuti depressivi, inibizione con esplosioni
Evolutivo	Gioco simbolico presente; immagine di sé centrata su bisogni primari
Ambientale	Contesto sfavorito, padre assente, madre con disturbo di personalità borderline

Diagnosi: F92.9 (disturbo misto emozioni/condotta) + Z63.8 + Z59.1

Intervento: psicoeducativo domiciliare + rete SPS + psicoterapia relazionale madre-bambino

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Anno
Marcelli	4 definizioni di normalità	1999
Winnicott	Sintomo come espressione evolutiva	(via Philipps, 1989)
Bergeret	Diagnosi strutturale	1974
Kernberg	Criteri formali diagnosi strutturale	1984
Palacio Espasa & Dufour	Griglia strutturale in età evolutiva	—
Anna Freud	<i>Normalità e patologia del bambino</i>	1969 (trad. it. 2003)

Parole chiave

sintomo · segno · norma statistica · falso sé · patognomonico · marker biologico · punto di fissazione · linee evolutive · regressione · anedonia · dismorfofobia · pruning · asse sindromico · asse strutturale · asse evolutivo · asse ambientale · Bergeret · Kernberg · Palacio Espasa · Winnicott